



Pancreatite Aguda e Pancreatite Crônica

Guia de revisão para provas de Gastroenterologia

Material produzido pela LAGEN — Liga Acadêmica de Gastroenterologia e Nutrologia

As pancreatites — agudas e crônicas — estão entre os temas mais cobrados em provas de Gastroenterologia. Este material organiza os pontos essenciais de cada uma: definição, causas, quadro clínico, diagnóstico, critérios de gravidade, complicações e tratamento.

1. Pancreatite Aguda

Pancreatite aguda (PA) é o processo inflamatório agudo do pâncreas, que pode envolver tecidos peripancreáticos e, em casos mais graves, outros órgãos à distância.

A classificação de Atlanta, criada em 1992 e revisada em 2012, consolidou a divisão da pancreatite aguda em dois subtipos:

- **Pancreatite edematosa intersticial:** aumento difuso ou localizado do pâncreas por edema inflamatório, sem necrose. Corresponde a 90-95% dos casos, é autolimitada (resolução geralmente em uma semana) e tem baixa morbimortalidade (cerca de 3%);
- **Pancreatite necrosante:** evolui com necrose do parênquima pancreático, dos tecidos peripancreáticos, ou de ambos. Ocorre em 5-10% dos casos, associada a quadros graves e mortalidade em torno de 17%.

A causa de morte na PA varia com o tempo de evolução: nas primeiras duas semanas, predomina a síndrome de resposta inflamatória sistêmica com falência de órgãos; depois disso, o óbito costuma decorrer de sepse ou outras complicações.

1.1 Etiologia

Causas comuns	Causas incomuns
Litíase biliar	Causas vasculares
Consumo de álcool	Doenças do tecido conjuntivo
Hipertrigliceridemia	Púrpura trombocitopênica trombótica
CPRE	Hipercalcemia
Medicamentos	Divertículo periampular
Trauma abdominal	Pâncreas divisum
Pós-operatório	Pancreatite hereditária • Fibrose cística • Infecções • Insuficiência renal • Pancreatite autoimune

No Brasil, o pódio das causas é: **1º litíase biliar**, **2º álcool**, **3º idiopática**. Vale a pena detalhar as principais:

- **Litíase biliar (40%):** é a causa mais frequente, embora apenas 3-8% dos portadores de cálculos biliares evoluam para pancreatite. Mais comum em mulheres de 50-70 anos; os cálculos menores que 5 mm são os que mais frequentemente migram e obstruem a ampola de Vater;
- **Álcool (30-35%):** segunda causa mais comum. A incidência entre etilistas é baixa (5-10% desenvolvem PA), dependendo da quantidade ingerida, do tabagismo associado e da suscetibilidade individual. Mais comum em homens jovens;
- **Hipertrigliceridemia:** responde por 1,3-3,8% dos casos, sobretudo quando os triglicérides ultrapassam 1000 mg/dL;
- **CPRE:** é a principal complicação desse procedimento — 5-10% dos submetidos a ele desenvolvem pancreatite, felizmente leve e autolimitada em 90-95% das vezes;
- **Medicamentos:** respondem por apenas 0,1-2% dos casos, geralmente com bom prognóstico. Os principais são sulfonamidas, metronidazol, tetraciclina, tiazídicos, furosemida, estatinas, azatioprina, sulfassalazina, 6-mercaptopurina, ácido valproico, acetaminofeno e alguns antirretrovirais;
- **Trauma abdominal:** principal causa em crianças;
- **Hipercalcemia:** causa incomum, mas cobrada — pensar em hiperparatireoidismo, hipercalcemia paraneoplásica, toxicidade por vitamina D e sarcoidose;
- **Alterações anatômicas:** o pâncreas divisum, presente em 10% da população, associa-se a um risco de 5-10% de PA ao longo da vida;
- **Idiopática:** corresponde a 25-30% dos casos, quando nenhuma etiologia é identificada.

1.2 Fisiopatologia

A teoria mais aceita é a da **autodigestão**: as enzimas proteolíticas (sobretudo a tripsina, ativada pela catepsina B) são ativadas precocemente ainda dentro das células acinares, digerindo o próprio tecido pancreático e peripancreático. Essa destruição celular ativa o complemento e libera substâncias vasoativas, causando vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular — o que pode evoluir para síndrome de resposta inflamatória sistêmica, falência orgânica (de qualquer órgão) e coagulação intravascular disseminada nos casos mais graves.

1.3 Manifestações clínicas

O paciente típico apresenta dor abdominal moderada a intensa no andar superior do abdome, com irradiação para o dorso ou "em faixa", associada a náuseas e vômitos.

A dor melhora na posição genupeitoral e piora em decúbito dorsal. Náuseas e vômitos ocorrem em 90% dos casos. A icterícia, presente em até 25%, decorre principalmente da etiologia biliar, mas também pode surgir por compressão do colédoco intrapancreático pelo edema da cabeça do pâncreas.

Ao exame físico, podem-se encontrar febre, taquicardia, hipotensão, taquipneia e hipoxemia (mais comuns nos casos graves), icterícia escleral, dor abdominal de intensidade variável (podendo ser difusa), distensão abdominal com ruídos hidroaéreos reduzidos e, eventualmente, massa palpável (necrose encapsulada, pseudocisto ou coleção líquida).

Os sinais de **Grey-Turner** (equimose em flancos) e de **Cullen** (equimose periumbilical) são muito cobrados em provas: indicam hemorragia retroperitoneal e mau prognóstico. Também merece nota o sinal de Fox (equimose na base do pênis) e a paniculite/necrose gordurosa subcutânea, mais comum nas extremidades.

1.4 Diagnóstico

O diagnóstico de pancreatite aguda exige **dois dos três critérios** abaixo:

1. Quadro clínico compatível (dor no andar superior do abdome com náuseas e vômitos);
2. Elevação de 3 ou mais vezes nos níveis de amilase e/ou lipase;
3. Achados característicos em exames de imagem.

Ou seja, o diagnóstico dispensa exame de imagem quando os critérios clínico e laboratorial já estão presentes.

1.4.1 Amilase e lipase

A **amilase** eleva-se em 6-12 horas do início do quadro, atinge pico em 48 horas e permanece elevada por 3-7 dias. Não é achado obrigatório: pode não se elevar em pancreatite alcoólica (cerca de 20% dos casos) e sua dosagem pode ser interferida pela hipertrigliceridemia em cerca de metade dos pacientes. Uma elevação acima de 3 vezes o limite superior tem sensibilidade de 67-87% e especificidade de 85-98%, mas diversas outras condições também cursam com hiperamilasemia (parotidite, macroamilasemia, tumores, doenças pulmonares, gestação ectópica, cetoacidose diabética, entre outras).

A **lipase** é considerada o marcador mais acurado, específico e com maior janela diagnóstica: eleva-se em 4-8 horas, atinge pico em 24 horas e permanece elevada por 8-14 dias.

Nem a amilase nem a lipase têm valor prognóstico: níveis mais elevados **não** significam pancreatite mais grave.

1.4.2 Outros marcadores e exames de imagem

Três critérios laboratoriais independentes de gravidade merecem memorização: **hematócrito > 44%**, **ureia > 20 mg/dL** e **PCR $\geq$ 150 mg/dL após 48 horas de evolução** (janela que, na prática, costuma corresponder ao 3º dia de internação).

A **ultrassonografia de abdome** é obrigatória na admissão — não para o diagnóstico da PA, mas para definir a etiologia biliar, devendo ser feita nas primeiras 48 horas.

A **tomografia computadorizada** não é obrigatória e é dispensável nos casos leves. Suas indicações são: dúvida diagnóstica, suspeita de complicações (nesse caso, só deve ser feita com contraste e após 72 horas do início dos sintomas, período mínimo para visualizar adequadamente áreas de necrose) e avaliação prognóstica pelo índice de gravidade tomográfico.

Grau	Achado tomográfico	Pontos
A	Pâncreas normal	0
B	Aumento focal ou difuso do pâncreas	1

Grau	Achado tomográfico	Pontos
C	Inflamação peripancreática com anomalias pancreáticas	2
D	Coleção líquida em uma localização	3
E	Duas ou mais coleções e/ou gás no pâncreas/adjacências	4

Necrose do parênquima	Pontos (necrose)	Soma (Balthazar + necrose)	Morbidade	Mortalidade
Nenhuma	0	0-1	0%	0%
< 30%	2	2-3	8%	3%
30-50%	4	4-6	35%	6%
> 50%	6	7-10	92%	17%

1.5 Avaliação da gravidade

Fatores de risco independentes: idade > 60 anos, obesidade (IMC > 30), história de alcoolismo e comorbidades (insuficiência cardíaca, renal ou hepatopatia) — mnemônico **CAIO** (Comorbidade, Alcoolismo, Idade, Obesidade).

1.5.1 Critérios de Ranson

Criados em 1974, ainda são o escore mais cobrado em provas. São 11 parâmetros: 5 avaliados na admissão e 6 nas primeiras 48 horas, com valores de corte diferentes conforme a etiologia seja biliar ou não.

Momento	Não biliar	Biliar
Admissão	AST > 250 U/dL Glicose > 200 mg/dL Idade > 55 anos Leucócitos > 16000/mm ³ LDH > 350 U/L	AST > 250 U/dL Glicose > 220 mg/dL Idade > 70 anos Leucócitos > 18000/mm ³ LDH > 400 U/L
Primeiras 48h	Aumento de ureia > 10 mg/dL Queda de Ht > 10% Perda líquida > 6 L BE < -4 mEq/L Cálcio < 8 mg/dL PaO ₂ < 60 mmHg	Aumento de ureia > 4 mg/dL Queda de Ht > 10% Perda líquida > 4 L BE < -5 mEq/L Cálcio < 8 mg/dL PaO ₂ < 60 mmHg

Mnemônicos úteis: admissão — **ÁGILL** (AST, Glicose, Idade, LDH, Leucócitos); 48 horas — frase "Urgente! Hoje Li Belíssimo Capítulo de Pancreatite" (Urgente=Ureia, HojE=Hematócrito, LI=perda de Líquido, BElíssimo=BE, CApítulo=Cálcio, PANcreatite=PaO₂).

Críticas: 6 dos 11 critérios só se completam após 48h. Valor preditivo positivo baixo (50%) e valor preditivo negativo alto (90%) — o escore serve mais para descartar gravidade. **Pancreatite é considerada grave com 3 ou mais critérios de Ranson.**

1.5.2 APACHE II

Escore complexo baseado em idade, comorbidades e 12 medidas fisiológicas, mas com a vantagem de poder ser calculado a qualquer momento da internação (diferente do Ranson, que exige 48h). É o mais validado entre os escores de gravidade na PA, embora atribua muitos pontos a pacientes com 75 anos ou mais (já começam com 6 pontos). Valor preditivo positivo de 49% e negativo de 89%. **Pancreatite é considerada grave quando APACHE ≥ 8.**

1.5.3 Classificação de Atlanta revisada (2012)

Gravidade	Critérios
Leve	Ausência de falência orgânica E ausência de complicações locais ou sistêmicas.
Moderadamente grave	Falência orgânica transitória (reversível em 48h) e/ou presença de complicações locais ou sistêmicas.
Grave	Falência orgânica persistente (não reversível em 48h).

São sinais de falência orgânica: pressão arterial sistólica < 90 mmHg; PaO₂ < 60 mmHg; creatinina > 2 mg/dL após ressuscitação volêmica; e sangramento gastrointestinal acima de 500 mL em 24 horas.

1.6 Complicações locais

Suspeitar de complicação quando houver: persistência ou recorrência da dor, novo aumento de amilase/lipase, piora da disfunção orgânica ou sinais de sepse (febre, leucocitose). As complicações locais, identificadas por TC com contraste, são:

Subtipo / Tempo	Pancreatite edematosa	Pancreatite necrosante
< 4 semanas	Coleção fluida peripancreática aguda (sem necrose)	Coleção necrótica aguda (com material necrótico)
> 4 semanas	Pseudocisto pancreático	Necrose pancreática murada (walled-off necrosis)

Pseudocisto pancreático: ocorre em 5-15% dos casos, definido como coleção encapsulada de líquido surgida após 4 semanas do início dos sintomas — uma complicação tardia. A cápsula não é verdadeira, sendo formada por debris inflamatórios e fibrose; na TC aparece como coleção redonda ou oval, bem delimitada, homogênea, com densidade de fluido, rica em amilase (por se originar da ruptura do ducto pancreático). Pode complicar com infecção, hemorragia, fístula pancreática, obstrução gastroduodenal/biliar ou pseudoaneurisma — mas a maioria (70%) regride espontaneamente.

Necrose pancreática murada (walled-off necrosis): coleção necrótica pancreática e/ou peripancreática com parede inflamatória bem definida, fibrótica e espessa, também tardia (após 4 semanas de uma pancreatite necrosante). Pode ser múltipla e infectar-se; mais comum na cauda e no corpo do pâncreas.

Cerca de um terço dos pacientes com necrose pancreática evolui para **infecção do tecido necrótico**. Suspeitar diante de gás no interior da coleção à TC contrastada (exceto se houve manipulação cirúrgica prévia) ou, em caso de dúvida, por punção aspirativa com agulha fina para cultura. A necrose infectada tem alta morbimortalidade e exige antibioticoterapia imediata — os principais patógenos são gram-negativos.

Outras complicações possíveis: trombose venosa portal e esplênica, ruptura do ducto pancreático (ascite pancreática e/ou derrame pleural) e pseudoaneurisma (por lesão vascular da elastase).

1.7 Tratamento

Não existe tratamento farmacológico específico para a pancreatite aguda. O manejo se apoia em três pilares:

Pilar	Pontos-chave
Ressuscitação volêmica	Etapa mais importante do tratamento; deve ser feita nas primeiras 12-24h, independentemente de instabilidade hemodinâmica, com cristaloides (SF 0,9% ou ringer lactato). Previne necrose por hipoperfusão pancreática.
Controle da dor	Deve ser tratada agressivamente nas primeiras 24h. Não há restrição a nenhuma classe de analgésico, incluindo opioides — exceto anti-inflamatórios não esteroidais em caso de injúria renal aguda.

Pilar	Pontos-chave
Manejo dietético	Pancreatite leve: dieta zero inicial com reintrodução precoce assim que houver controle da dor (líquida, pobre em gordura). Pancreatite grave: preferir nutrição enteral precoce à parenteral total, pois preserva a mucosa intestinal e reduz translocação bacteriana; posição gástrica ou jejunal da sonda são igualmente seguras. Não é necessário aguardar normalização de amilase/lipase para iniciar dieta — basta melhora de dor, náuseas/vômitos e ausência de íleo paralítico.

Antibioticoterapia **profilática não é recomendada** na pancreatite aguda. O uso só se justifica na vigência de infecção confirmada, preferindo-se drogas com boa penetração pancreática e cobertura para gram-negativos, gram-positivos e anaeróbios — os **carbapenêmicos** (especialmente o imipenem) são a escolha, já que os principais patógenos da necrose infectada são gram-negativos (*Escherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa*).

1.7.1 Tratamento das complicações

Complicação	Conduta
Pseudocisto pancreático	Assintomático e não infectado: conduta expectante (70% regridem sozinhos). Infectado, sintomático ou em crescimento: drenagem endoscópica (preferencial — transgástrica ou transduodenal conforme proximidade; transpapilar se comunica com o ducto principal; stent se houver estenose ductal) ou percutânea guiada por imagem. Falha endoscópica: cirurgia (cistogastrotomia, cistoduodenostomia ou cistojejunostomia em Y de Roux, esta última para pseudocistos sem contato com estômago/duodeno).
Necrose estéril	Conduta expectante; sem indicação de antibioticoprofilaxia. Necrosectomia só se houver dor persistente que impeça alimentação ou disfunção orgânica persistente — idealmente adiada por ao menos 10 dias e realizada preferencialmente após 4 semanas.
Necrose infectada	Antibioticoterapia intravenosa (carbapenêmico de escolha) + drenagem percutânea (primeira linha, minimamente invasiva, resolve 20-60% dos casos). Falha terapêutica: necrosectomia minimamente invasiva (endoscópica transgástrica ou desbridamento retroperitoneal vídeo-assistido) ou via aberta, preferencialmente após 4 semanas.

1.7.2 Manejo da etiologia biliar

Colecistectomia: indicada a todo portador de pancreatite biliar. Na PA leve, deve ser feita na mesma internação, para evitar recidiva. Na PA mais grave, com coleções peripancreáticas, adia-se até a estabilização/resolução das coleções.

CPRE com papilotomia: não deve ser feita de rotina na emergência para todo paciente com pancreatite biliar — só está indicada se houver colangite (triade de Charcot: icterícia, febre e dor abdominal) ou obstrução comprovada do colédoco.

2. Pancreatite Crônica

A **pancreatite crônica (PC)** caracteriza-se pela substituição do parênquima pancreático normal por áreas de fibrose e por alterações anatômicas dos ductos (irregularidades e estenoses), secundárias à inflamação crônica — resultando em perda progressiva da função pancreática exócrina e endócrina. É uma doença **irreversível e progressiva**.

Pancreatite aguda e crônica não são entidades totalmente separadas: episódios recorrentes de PA podem evoluir para PC. No Brasil, a PC é mais prevalente na região Sudeste, possivelmente pelo consumo mais elevado de álcool.

2.1 Etiologia e fatores de risco

Categoria	Detalhes
Tóxico-metabólicas	Álcool (principal causa, 70-80% dos casos, embora apenas 3-7% dos etilistas evoluam para PC) • Tabagismo (age em sinergia com o álcool) • Hipertrigliceridemia > 1000 mg/dL • Medicamentos • Hipercalcemia
Idiopática	10-20% dos casos; inclui a pancreatite tropical, de início na infância em regiões tropicais
Genética	Mutações nos genes PRSS1, CFTR, SPINK1, CTSC e CASR
Recidivas/Recorrência	10% dos pacientes evoluem para PC após um episódio de PA; risco maior nas formas necrosantes
Autoimune	Tipo I (esclerosante linfoplasmocitária, associada a doença sistêmica por IgG4, com IgG4 sérico elevado) e Tipo II (ducto-cêntrica idiopática/lesão granulocítica). Ambas respondem bem a corticosteroides
Obstrutiva	Tumores pancreáticos, cálculos ductais, retrações fibróticas, cistos da parede duodenal; pâncreas divisum é causa questionável em adultos

Mnemônico para as causas/fatores de risco: **TIGRÃO** — Tóxico-metabólicas, Idiopática, Genética, Recidivas, Autoimune, Obstrução.

2.2 Manifestações clínicas

- **Dor abdominal:** início insidioso, principal sintoma (embora uma minoria seja assintomática), geralmente progressiva, epigástrica com irradiação para o dorso, associada à alimentação — o que leva o paciente a evitar comer e perder peso;
- **Má digestão:** a perda da função exócrina leva à disabsorção — diarreia crônica, esteatorreia, fadiga e emagrecimento. É necessário perder cerca de 90% da capacidade secretora exócrina para surgir má digestão clínica, por isso a esteatorreia costuma aparecer só após 5-10 anos de doença. Hipovitaminoses A, D, E e K podem ocorrer em casos graves;
- **Diabetes mellitus:** surge em 40-80% dos pacientes, geralmente anos após o início da dor e da disabsorção, por perda da função endócrina das ilhotas;
- **Icterícia e colangite:** ocorrem em 5-10% dos casos, por fibrose da porção distal do colédoco.

Paciente típico: histórico de alcoolismo/tabagismo/episódios prévios de PA, dor epigástrica de intensidade variável, perda de peso, esteatorreia e diabetes mellitus. Nos estágios iniciais, pode ser assintomático ou oligossintomático.

2.3 Complicações

Complicação	Pontos-chave
Pseudocisto pancreático	Ocorre em 10-40% dos portadores de PC, com comportamento semelhante ao descrito na pancreatite aguda.
Obstrução do ducto biliar	Ocorre em 5-10% dos casos, cursando com dor, icterícia, colestase e, em casos avançados, cirrose biliar.
Obstrução duodenal	Dor abdominal pós-prandial e saciedade precoce.
Pseudoaneurisma	Mais comum na artéria esplênica (40%), seguida da gastroduodenal (30%); quadro clínico variável, de dor leve a hemorragia grave.
Derrames intracavitários	Ascite pancreática ou derrame pleural.
Trombose de veia esplênica	Presente em 11% dos casos; pode causar hipertensão no sistema porta e varizes gástricas, com risco de sangramento; pode haver esplenomegalia.
Insuficiência endócrina	Diabetes mellitus de difícil controle em 30-50% dos pacientes, geralmente anos após o início da doença.
Câncer de pâncreas	Risco aumentado pela inflamação crônica; sintomas se confundem com os da própria PC (dor, emagrecimento, icterícia).

2.4 Diagnóstico

Diferentemente da pancreatite aguda, a PC não cursa com elevações marcantes de amilase e lipase, o que dificulta o diagnóstico laboratorial isolado.

2.4.1 Exames de imagem

Tomografia computadorizada: sensibilidade de 56-95% e especificidade de 85-100%; é um dos exames mais disponíveis. Achados: atrofia pancreática (54%), dilatação do ducto pancreático (68%) e calcificações parenquimatosas/intraductais (50%). Em casos de PC de início precoce, pode não mostrar alterações conclusivas.

Ressonância magnética com colangiopancreatografia (CPRM): parece superior à TC para detectar alterações ductais em fases mais iniciais, mas é mais cara e menos disponível. Achados variam desde ducto normal (casos iniciais) até irregularidades leves, estreitamentos focais com dilatação, ectasia de ramos laterais e atrofia glandular.

Na suspeita de pancreatite crônica **inicial**, o exame de escolha é o ultrassom endoscópico (USE).

2.4.2 Testes funcionais

Avaliam a insuficiência pancreática exócrina, principal desfecho funcional da PC:

Teste	Interpretação
Elastase fecal	100-200 mcg/g: insuficiência leve. < 100 mcg/g: insuficiência grave.
Gordura fecal	Excreção > 7 g/dia define esteatorreia.
Teste da secretina	Bicarbonato $\geq$ 80-90 mEq/L: normal. 30-75% do valor normal: insuficiência moderada. $\leq$ 30%: insuficiência grave.
Teste da colecistocinina	Tripsina < 50 mcg/kg/h sugere insuficiência exócrina.
Teste da bentiromida	Excreção de PABA $\geq$ 70%: normal. < 50%: sugestiva de insuficiência exócrina.
Tripsinogênio sérico	< 20 ng/mL sugere insuficiência pancreática exócrina.
Teste respiratório com carbono-13	Relação $^{13}\text{CO}_2/^{12}\text{CO}_2$ reduzida.
Teste da D-xilose	Baixa (< 6,0 $\pm$ 1,5 g ou < 20 mg/dL): má absorção por doença da mucosa intestinal. Normal: sugere má absorção por problema digestivo, como na PC.

De forma resumida: quase todos os testes se apresentam reduzidos na PC — exceto a gordura fecal (aumentada) e o teste da D-xilose (normal).

2.5 Tratamento clínico

O objetivo não é reverter a doença, mas aliviar sintomas e, quando possível, retardar sua progressão, idealmente com equipe multidisciplinar. As metas são controle da dor, melhora da insuficiência pancreática e tratamento das complicações.

Ao alcance do paciente estão a cessação do álcool e do tabagismo e dieta pobre em gorduras em caso de hipertrigliceridemia. A suplementação com triglicérides de cadeia média tem sido estudada, com benefícios sugeridos (possível aumento de colecistocinina e efeito antioxidante).

Para a dor, recomenda-se analgesia escalonada conforme a intensidade, podendo incluir opioides. Como a dor tem componente neuropático, também são úteis antidepressivos (tricíclicos ou inibidores da recaptação de serotonina), anticonvulsivantes (gabapentina) e ansiolíticos (pregabalina).

A **suplementação de enzimas pancreáticas** traz benefício claro para o distúrbio digestivo (embora seu efeito sobre a dor seja controverso), reduzindo a disabsorção e a esteatorreia. Vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K) devem ser suplementadas quando houver insuficiência exócrina associada. Os triglicérides de cadeia média — que dispensam formação de micelas e estimulam pouco a secreção pancreática — são úteis em pacientes com perda ponderal importante e pouca resposta à suplementação enzimática.

2.6 Tratamento cirúrgico

Indicações: dor refratária (a principal e mais cobrada), obstrução biliar ou pancreática, obstrução duodenal, pseudocisto, pseudoaneurisma e suspeita de neoplasia. Entre 40-75% dos pacientes falham ao tratamento clínico e endoscópico e acabam encaminhados à cirurgia, cujos objetivos são aliviar a dor de forma eficaz e duradoura, minimizar a morbidade e preservar ao máximo o parênquima pancreático.

A escolha da técnica depende de dois fatores: a presença de dilatação do ducto pancreático principal (> 7 mm indica procedimento de descompressão; < 7 mm indica ressecção) e a localização predominante da doença.

Cenário	Técnica indicada
Ducto dilatado (> 7 mm), sem fibrose/drenagem ruim na cabeça	Pancreaticojejunostomia lateral (cirurgia de Puestow).
Ducto dilatado (> 7 mm), com fibrose/drenagem ruim na cabeça	Pancreaticojejunostomia lateral com ressecção pancreática localizada (cirurgia de Frey).
Ducto não dilatado, doença predominante na cabeça	Duodenopancreatectomia clássica (Whipple), com preservação pilórica (Transverso-Longmire) ou ressecção da cabeça com preservação duodenal (Beger).
Ducto não dilatado, doença predominante na cauda	Pancreatectomia distal (corpo-caudal).
Ducto não dilatado, doença difusa	Pancreatectomia total com autotransplante de ilhotas pancreáticas.

Material produzido pela LAGEN — Liga Acadêmica de Gastroenterologia e Nutrologia — para fins de estudo e revisão sobre pancreatite aguda e crônica.